

CAPÍTULO 6.15

Retinopatía Diabética

PERFIL EUNACOM 1.04.1.013

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Retinopatía Diabética

Causa frecuente de ceguera irreversible. El screening y diagnóstico se realiza con **Fondo de Ojo fotográfico con dilatación pupilar** una vez al año.

Edema Macular

- Puede ocurrir en **cualquier etapa** de la retinopatía.
- Genera **disminución progresiva** de la agudeza visual.
- Causado por exudados céreos invadiendo la mácula.
- **Tratamiento:** Fotocoagulación + Fármacos Antiangiogénicos (Anti-VEGF) intravítreos.

Clasificación de la Retinopatía Diabética

1. Retinopatía Diabética No Proliferativa (RDNP)

Progresas gradualmente. Habitualmente asintomática (salvo que haya edema macular). 1. Muerte de pericitos. 2. **Exudados céreos** (puntitos amarillos, edema real). 3. **Microaneurismas** (puntitos rojos). 4. **Microhemorragias** (manchitas rojas más grandes en parches). 5. **Exudados algodinosos** (manchas blancas: microinfartos de la retina). - **Tratamiento:** Control estricto de la diabetes (metabólico). Fotocoagulación/Anti-VEGF solo si es muy severa o tiene edema macular.

2. Retinopatía Diabética Proliferativa (RDP)

Paso final y grave. - Ausencia de capilares provoca isquemia retiniana intensa, estimulando VEGF. - Desarrollo de **Neovasos** (vasos de neoformación). Estos vasos son frágiles y tienden a sangrar. - Asintomática *hasta* que sangra. - **Tratamiento obligatorio:** Fármacos **Antiangiogénicos** intravítreos (Ranibizumab) + **Fotocoagulación láser** panretiniana.

Complicación Mayor: Hemorragia Vítrea

- Ruptura de un neovaso sangrando hacia la cavidad vítrea.
- **Clínica:** **Amaurosis súbita** unilateral.
- **Hallazgo cardinal:** Al examen con oftalmoscopio, hay **pérdida del rojo pupilar**.
- **Tratamiento:** Inicialmente expectante (observación para reabsorción). Si es masiva, no reabsorbe o es en pacientes monóculos → cirugía de **Vitrectomía**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 60 años con DM2 de 18 años de evolución consulta por disminución progresiva de agudeza visual. Fondo de ojo revela neovasos en papila y retina con microhemorragias difusas."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Retinopatía Diabética Proliferativa: caracterizada por la presencia de neovascularización. Es indicación de Panfotocoagulación con Láser de urgencia o inyección intravítrea de anti-VEGF para prevenir hemorragia vítrea y desprendimiento traccional de retina.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera adquirida en adultos en edad laboral
- Tamizaje con fondo de ojo: anual desde diagnóstico en DM2, desde 5 años en DM1
- RDNP severa se define por la regla 4-2-1
- La RDP se caracteriza por neovascularización
- El edema macular diabético es la principal causa de pérdida visual en diabéticos
- Fotocoagulación panretiniana es el tratamiento estándar de la RDP
- Anti-VEGF intravítreo se usa para edema macular diabético

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RETINOPATÍA DIABÉTICA)

PREGUNTA 1

Paciente de 50 años con DM2 de 15 años. Fondo de ojo muestra microaneurismas, hemorragias retinianas en los 4 cuadrantes y arrosariamiento venoso en 2 cuadrantes. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Retinopatía no proliferativa leve
- B)** Retinopatía no proliferativa moderada
- C)** Retinopatía no proliferativa severa
- D)** Retinopatía proliferativa
- E)** Edema macular diabético

PREGUNTA 2

¿Cuál es el tratamiento estándar de la retinopatía diabética proliferativa?

- A)** Solo control glicémico estricto
- B)** Fotocoagulación panretiniana con láser
- C)** Corticoides sistémicos
- D)** Vitrectomía de rutina
- E)** Colirios de betabloqueadores

PREGUNTA 3

¿Cuál es la principal causa de pérdida de visión en pacientes diabéticos?

- A)** Hemorragia vítrea
- B)** Desprendimiento de retina
- C)** Edema macular diabético
- D)** Glaucoma neovascular
- E)** Catarata diabética

RESUMEN: RETINOPATÍA DIABÉTICA

La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera adquirida en adultos en edad laboral. Es una complicación microvascular que afecta a más del 30% de los diabéticos y su principal factor de riesgo es la duración de la diabetes y el mal control glicémico. El tamizaje se realiza con fondo de ojo con dilatación pupilar, anualmente desde el diagnóstico en DM2 y desde los 5 años en DM1. Se clasifica en retinopatía diabética no proliferativa (RDNP) y proliferativa (RDP). La RDNP se subdivide en leve (solo microaneurismas), moderada (microaneurismas, hemorragias retinianas, exudados duros) y severa (regla del 4-2-1: hemorragias en 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso en 2 cuadrantes o anomalías microvasculares intrarretinianas en 1 cuadrante). La RDP se caracteriza por neovascularización, que es la formación de nuevos vasos frágiles que pueden causar hemorragia vítrea y desprendimiento de retina traccional. El tratamiento incluye control glicémico estricto y control de la presión arterial. La fotocoagulación con láser panretiniana es el tratamiento estándar de la RDP. Las inyecciones intravítreas de anti-VEGF (bevacizumab, ranibizumab, aflibercept) se usan para el edema macular diabético y como coadyuvante en RDP. La vitrectomía se indica en hemorragia vítrea persistente o desprendimiento de retina traccional.